核心精讲

其它外科总论

性感认识：先会点再说

一、无菌术

外科　休克&其他外科总论
01:07:15--01:12:24

1.灭菌（杀灭芽孢）蒸、煮、泡、低温料理、烧烤、微波炉

①高压蒸汽（最常用）：适合大多数物品，有效期2周

②化学气体（环氧乙烷、过氧化氢低温等离子体、低温甲醛蒸汽）：不耐高温如仪器、导管、内镜（胰岛内分泌）

③煮沸持续1小时：耐高温如金属器械、玻璃、橡胶

④戊二醛等化学药液浸泡10小时：锐利器械、内镜

⑤干热/火烧：玻璃、粉剂、油剂

⑥电离辐射（γ射线）

2.手术区

①皮肤消毒范围包括切口周围15cm，由中心向四周消毒（但感染区/肛门区由外周开始）

②无菌区域：肩部以下、腰部以上的身前区（至腋中线）、双侧手臂、手术台面以上

③手术时若手套破损或接触到有菌地方→重新洗手+消毒+更换手套

④手术室：

铜绿假单胞菌、气性坏疽	40%甲醛+高锰酸钾熏蒸（高钾血症气绿了）
铜绿假单胞菌、乙肝、开放性结核	器械在2000mg/L有效氯中浸泡1小时+高压蒸汽灭菌（绿甘蔗真绿）

二、急性肝衰竭

外科　休克&其他外科总论
01:12:24--01:13:48

①我国最主要原因：乙肝

②肝性脑病（扑翼样震颤、肝臭），肝浊音界进行性缩小，凝血酶原活动度PTA≤40%、胆酶分离

「理顺知识点」

- 肝浊音界缩小见于
  - 肝衰竭（肝实质萎缩）
  - 消化性溃疡穿孔（消化道气体进入腹腔→聚集在肝脏周围→影响肝浊音界的查体）
- 胆酶分离：胆红素持续升高（肝功能不全），但转氨酶不升高（肝细胞几乎完全坏死，不会产生转氨酶），提示病情危重

三、创伤

外科　休克&其他外科总论
01:13:48--01:17:00

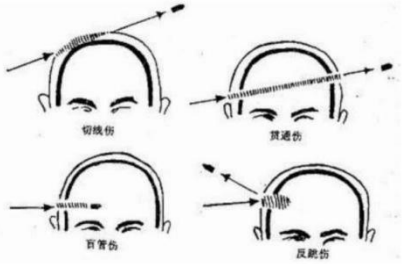
1.按伤后皮肤或黏膜完整性分类：闭合伤、开放伤（贯通伤和盲管伤）

2.止血带

①适合加压包扎无法止血的四肢大出血

②禁用细绳、电线

③每隔1小时放松1-2分钟、使用不超过4小时



3.开放伤清创

①切除创缘皮肤1-2mm

②伤后6-8小时内（头面部12小时内、头皮24小时内）：清创后一期缝合（头皮一天都丝滑）

③超过时间、火器伤、渗液多/污染重/感染几率大：清创后不一期缝合

4.优先抢救危及生命的：心跳呼吸骤停、窒息、张力性气胸、休克等

四、移植

外科　休克&其他外科总论
01:17:00--01:19:19

①组织移植：角膜、皮肤、皮肌瓣

②超急性排斥反应：受者血液中已有供者特异性HLA（白细胞抗原）抗体、或供者与受者ABO血型（红细胞抗原）不符（我准备好了）

③移植中疗效最显著：肾（慢性排斥反应是最大障碍）

④排斥反应发生率最高、易并发严重感染、易发生GVHD：小肠

「理顺知识点」

- 超急性排斥反应可通过交叉配型试验有效预防，急性排斥反应可用激素、免疫抑制剂控制
  但慢性排斥反应尚无有效干预手段　eg.心脏发生慢性排斥反应导致冠状动脉粥样硬化，影响患者术后生存率

五、微创

外科　休克&其他外科总论
01:19:19--01:19:54

腹腔镜手术可有与CO_2气腹相关的并发症

六、肿瘤

外科　休克&其他外科总论
01:19:54--01:32:42

1.预防

一级预防（对因）：防止癌症发生（戒烟、疫苗等）

二级预防：高危人群定期筛查、早发现早诊断早治疗

三级预防：姑息、对症治疗

2.癌痛止痛

①非阿片类如阿司匹林→弱阿片类如可待因→强阿片类如吗啡→药物以外的治疗

②从小剂量开始、视止痛效果逐渐增量，定期给药，口服→直肠→注射

3.抗肿瘤药举例

细胞毒素类	环磷酰胺
抗代谢类	氟尿嘧啶、甲氨蝶呤、阿糖胞苷
抗生素类	放线菌素、丝裂霉素、阿霉素、博来霉素
生物碱类	长春碱、紫杉醇
激素类	泼尼松、三苯氧胺/他莫昔芬
靶向药	伊马替尼、赫赛汀、美罗华

「理顺知识点」

- 环磷酰胺：用于急性肾炎、肾病综合征、风湿系统疾病「环球」
- 氟尿嘧啶、甲氨蝶呤、阿糖胞苷均为核苷酸代谢抑制物
- 氟尿嘧啶用于消化道恶性肿瘤
- 甲氨蝶呤用于
  - 中枢白血病的化疗：鞘内注射甲氨蝶呤（首选）
  - 类风湿关节炎改善病情的药物
- 长春碱用于ITP、急淋、非霍奇金淋巴瘤
- 紫杉醇用于乳腺癌的化疗（TC/ETC方案）
- 三苯氧胺/他莫昔芬：雌激素受体拮抗剂
- 伊马替尼/格列卫：用于慢粒（针对BCR−ABL融合基因）、胃肠间质瘤（针对Kit）
- 赫赛汀：用于乳腺癌（HER2+→靶向治疗）「去喝」
- 美罗华：CD20+加用利妥昔单抗/美罗华（R−CHOP）「二美丽」

4.常见体表肿瘤与囊肿

①皮肤基底细胞癌（低度恶性）：多见于老年人头面部，浸润性生长、生长缓慢、很少转移，伴黑色素增多者破溃后呈鼠咬状。对放疗敏感，手术切除效果好（老头慢放羊、放老鼠药）

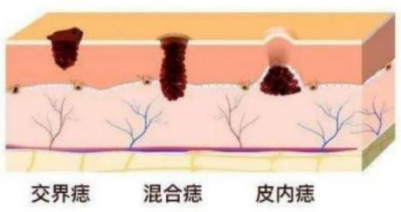
②黑色素瘤（高度恶性的体表肿瘤）：不对称、不规则、不均匀、＞6mm

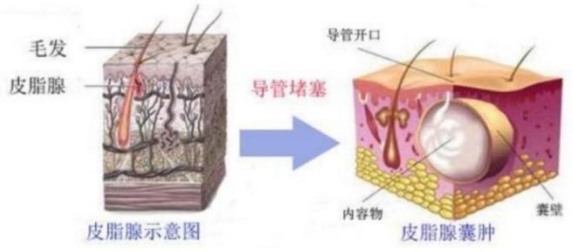
③交界痣：在基底细胞层（易恶变），警惕手掌/足底/皮带区痣恶变如出血、破溃、色素加深、变大、瘙痒、疼痛

④脂肪瘤：质软、分叶状、切面呈黄色

⑤皮脂腺囊肿：好发于头面和背部，表面有小黑点、囊内有豆渣物

⑥皮样囊肿（单胚层囊性畸胎瘤）：好发于眉梢和颅骨骨缝，哑铃状







真题解析·无菌术、肝衰竭、创伤、肿瘤、移植、微创

外科　休克&其他外科总论
01:32:42--01:33:48

1.2015N82A男性，46岁。左耳后有圆形肿物3年，直径1cm，肿物表面可见一小黑点，基底活动，无压痛，曾有红肿史。该患者诊断的疾病是

A.血管瘤

B.皮脂腺囊肿

C.皮样囊肿

D.淋巴结炎

2.2018N58A因受者体内存在针对供者特异性抗原的预存抗体所引起的排斥反应是

A.超急性排斥反应

B.加速性排斥反应

C.急性排斥反应

D.慢性排斥反应

　答案：1-2 B A